

Простая простатэктомия

WARWIKI

Информация для пациента · Операция при значительно увеличенной простате (BPH)

Простая простатэктомия — операция при **значительно увеличенной простате (доброкачественная гиперплазия простаты, BPH)**, которая затрудняет мочеиспускание. Хирург удаляет увеличенную внутреннюю часть простаты через брюшную полость — открытым способом или с помощью роботической/лапароскопической техники. Метод высокоэффективен при больших железах.

Важное отличие

«Простая» простатэктомия — это **не то же самое**, что «радикальная» простатэктомия при **раке** простаты. Радикальная операция удаляет всю железу для лечения рака. **Простая** простатэктомия удаляет только увеличенную внутреннюю (доброкачественную) ткань, оставляя наружную оболочку — она устраняет **закупорку, вызванную незлокачественным увеличением**.

Когда применяется

- При **очень большой простате**, которая не подходит для стандартной эндоскопической операции (TURP)
- Особенно если одновременно имеются **камни мочевого пузыря** или большие дивертикулы
- Эндоскопические варианты для крупных желёз (**HoLEP, Aquablation**) — альтернативы; врач поможет выбрать подходящий метод

ТЕРМИНЫ

Простая простатэктомия

Удаление увеличенной внутренней части простаты при BPH (не при раке).

Аденома

Доброкачественная внутренняя ткань простаты, которую удаляют.

Радикальная простатэктомия

Другая операция — полное удаление простаты при раке.

Открытая vs. роботическая

Через один разрез или через маленькие лапароскопические проколы.

Ретроградная эякуляция

Сухой оргазм — частое последствие операции.

Катетер

Трубка для отведения мочи из мочевого пузыря в первые дни после операции.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под общей анестезией — вы ничего не чувствуете.

Поскольку это операция на брюшной полости, восстановление **дольше, чем после эндоскопических вмешательств**: несколько дней в стационаре (меньше при роботической технике), катетер на несколько дней и ограниченная активность в течение нескольких недель.

Как подготовиться

- Операция под **общей анестезией** — соблюдайте режим голодания и указания по приёму лекарств (при необходимости отмените антикоагулянты).
- **Анализ мочи** для исключения инфекции.
- Не курите; организуйте сопровождение домой и помощь на период восстановления.

Что происходит & После

- 1 Вы находитесь под наркозом; вводятся антибиотики.
- 2 Через брюшной (открытый) или роботический/лапароскопический доступ удаляется увеличенная внутренняя часть простаты; наружная оболочка остаётся.
- 3 Устанавливается катетер (иногда дренаж); пребывание в стационаре — несколько дней (меньше при роботической технике).
- 4 Катетер, как правило, стоит **несколько дней — около недели**.

В первое время возможна примесь крови в моче; **избегайте подъёма тяжестей и натуживания** в течение нескольких недель.

Чего ожидать после

- Значительное и стойкое улучшение струи мочи.
- **Ретроградная эякуляция** (сухой оргазм) встречается часто; серьёзные нарушения эрекции или удержания мочи — редкость.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Нет мочеиспускания** после удаления катетера
- **Сильное кровотечение или сгустки крови**, жар или озноб
- Нарастающая боль в животе, покраснение или выделения из раны
- Боль в груди, затруднённое дыхание или отёк и боль в ноге (срочно!)

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Простая простатэктомия удаляет увеличенную внутреннюю ткань при очень крупной ВПН — это **не** онкологическая операция (которая удаляет всю простату).
2. Метод очень эффективен при большой железе; восстановление длится дольше, чем после эндоскопических операций (HoLEP/Aquablation — эндоскопические альтернативы).
3. Ожидайте сухую эякуляцию и катетер на несколько дней. Звоните врачу при отсутствии мочеиспускания, сильном кровотечении или жаре.